

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Breast Surgery – Wide Local Excision

+/- Sentinel Lymph Node Biopsy +/- أخذ عينة (خزعة) للعقد الليمفاوية الحارسة (الأسرع في الإصابة بالمرض)

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:

Wide Local Excision

Complete removal of the breast lump. Whilst still under anaesthetic, the pathologist may examine the lump to confirm that it did contain cancer. Some of the lymph nodes in the armpit on the same side of the cancer will also be removed for pathology tests for any evidence of cancer spread.

Sentinel Lymph Node Biopsy

This may be an alternative. This procedure is still considered experimental but is widely practiced in centres of excellence around the world. Final results from research will take up to another five (5) years. This alternative has found to reduce complications:

- reduced lymphoedema risk
- reduced risk of shoulder stiffness
- reduced risk of numbness in the axilla

Sentinel lymph node biopsy may be an alternative to routine axillary (under the arm) dissection in

أ. مترجم / احتياجات ثقافية

الحاجة إلى وجود مترجم؟ ☐ نعم ☐ لا
إذا كانت الإجابة نعم، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ نعم ☐ لا

ب. الحالة المرضية والعلاج

لقد قام الطبيب بشرح حالتك المرضية لك وأنت تعاني من: (يقوم الطبيب بالتوثيق بما يلائم لغة ومفردات المريض)

تتطلب هذه الحالة المرضية الإجراء الطبي التالي
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يشمل ذلك موضع و/أو الجهة المتعلقة بالإجراء)

سيتم القيام بالإجراء التالي:
إزالة موضعية واسعة النطاق
إزالة كاملة للكتلة الموجودة في الثدي، وأثناء بقاء المريض تحت التخدير، قد يقوم اختصاصي علم الأمراض بفحص الكتلة للتأكد من خلوها من الخلايا السرطانية.
تتم أيضاً إزالة بعض العقد الليمفاوية من منطقة الإبط القريب من الكتلة السرطانية لإخضاعها للفحص من قبل اختصاصي علم الأمراض للبحث عما يدل على انتشار السرطان.

أخذ عينة (خزعة) من العقد الليمفاوية الحارسة (الأسرع في الإصابة بالمرض)

قد يكون هذا الإجراء بديل. لا يزال هذا الإجراء يعد من الإجراءات الخاضعة للتجربة، إلا أنه يمارس على نطاق واسع في مراكز الامتياز حول العالم. النتائج النهائية للأبحاث قد يستغرق ظهورها خمس (5) سنوات أخرى. لقد وجد أن هذا الخيار البديل يقلل المضاعفات مثل:

- يقلل مخاطر الإصابة بالوذمة (الاستسقاء) اللمفاوي
- يقلل مخاطر الإصابة بتصلب مفصل الكتف
- يقلل مخاطر الإصابة بخدر في منطقة الإبط

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

selected patients. This involves the removal of the lymph node(s) that the area of the breast, in which the tumour lies, would drain to first.

These are localised (pin pointed) by a nuclear scan (lymphoscintigraphy) and /or blue dye (patent blue V) injection, just prior to surgery.

If the sentinel lymph node is not involved, then it is highly unlikely that any of the other lymph nodes in the armpit are involved and the risk of complications from standard axillary dissection (shoulder stiffness, armpit tenderness and lymphoedema) are reduced.

The decision whether or not to have a mastectomy is made before the operation, and will not be made during the operation.

C. Risks of Breast Surgery – Wide Local excision +/- Sentinel Lymph Node Biopsy

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and further treatment.
- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.

عند بعض المرضى ، قد يكون أخذ عينة من هذه العقد الليمفاوية إجراءً بديلاً للعملية الجراحية التشرحية المعتادة في منطقة الإبط . يشمل ذلك إزالة العقدة أو العقد الليمفاوية التي تقوم بشكل مباشر باستقبال سائل اللمف القادم من منطقة الثدي المصابة بالورم.

ويتم قبل العملية مباشرة تحديد هذه العقد الليمفاوية بشكل متناهي الدقة عن طريق التصوير النووي للخريطة الليمفاوية (ليمفوسينوجرافي) ، وقد يكون ذلك مصاحباً لاستخدام صبغة زرقاء (باتنت بلو في) أو من دونها.

إذا كانت العقدة/العقد الحارسة غير مصابة بالخلايا السرطانية ، فمن المستبعد جداً أن تكون أيّاً من العقد الليمفاوية الأخرى في الإبط قد أصيبت وبالتالي فإن ذلك يقلل من مضاعفات الجراحة التشرحية التقليدية (تصلب مفصل الكتف، الشعور بألم عند ملامسة الإبط والاستسقاء الليمفي).

إن القرار المتعلق باستئصال كامل الثدي من عدمه يتم اتخاذه قبل إجراء العملية الجراحية وسوف لن يتخذ أثناءها.

ج. مخاطر جراحة الثدي- الإزالة الموضعية واسعة النطاق +/- أخذ عينة(خزعة) للعقد الليمفاوية الحارسة لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر عامة:

- قد تحدث عدوى ، مما يتطلب العلاج بالصادات الحيوية وعلاجات أخرى
- قد يعقب أخذ العينة حدوث نزيف مما قد يتطلب إعادتك مرة أخرى لغرفة العمليات لإيقافه. حدوث النزيف أكثر شيوعاً إذا كنت ممن يتناولون العقاقير التي تؤدي لزيادة سيولة الدم مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل(بلافيكس أو اسكوفير) أو عقار دايابيردامول(بيرسانتن أو اساسانتن)
- قد يحدث انهيار(انطباق) لمناطق صغيرة في الرئة، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب في الصدر، وقد يتطلب علاج ذلك استخدام المضادات الحيوية والعلاج الطبيعي(الفيزيائي) للصدر.
- عند أصحاب الأوزان الزائدة ، تزداد مخاطر الإصابة بعدوى والتهاب الجرح والصدر ، مضاعفات في القلب والرئة ، وجلطات الأوعية الدموية.
- قد ينتج عن إجهاد القلب حدوث أزمة قلبية أو سكتة دماغية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- The operation site under the arm continues to ooze fluid, which collects beneath the cut. This may need to be drained with a needle and syringe.
- The layers of the wound may not heal adequately and the wound may burst open. This may require long term wound care with dressings and antibiotics.
- The wound may not heal normally. The scar can be thickened and red and may be painful. This is permanent and can be disfiguring.
- Loss of sensation to the nipple when the surgery is close to the nipple. This may be permanent.
- Difficulty with arm movement due to shoulder stiffness and scarring under the arm after the operation. This is usually temporary when treated with physiotherapy and/ or exercises.
- Swelling of the arm (lymphoedema) on the side of the operation. It is usually treated with a special type of garment, which squeezes the arm to reduce the fluid build-up. Regular massage is also used.
- Loss of sexuality due to distress at the change in body image or depression due to the disease. Professional counselling before and after the surgery may help.
- The tumour may grow again in or around the scar. This may need further treatment such as surgery, chemotherapy or radiotherapy or a combination of all three.
- Feelings of anxiety and depression due to the disease and possible recurrence.
- Increased risk in smokers of wound and chest

- تجلط في أحد أوردة الساق (تجلط الوريد العميق للساق) مم يسبب ألم وتورم في الساق ، وفي حالات نادرة قد ينفصل جزء من التجلط ليصل إلى الرئة.
- قد تحدث الوفاة كنتيجة للقيام بهذا الإجراء.

مخاطر متعلقة بهذا الإجراء خصوصاً :

- قد يتواصل تسرب وخروج سوائل من موضع العملية تحت الذراع وتجمعها تحت القطع (الجرح) قد يستدعي ذلك سحب السوائل باستخدام إبرة و محقنة (حقنة).
- قد لا تلتئم طبقات الجرح بشكل كاف وقد ينفث الجرح بشكل مفاجئ ، ويتطلب ذلك عناية بالجرح لفترة زمنية طويلة مع عمل الغيارات للجرح واستخدام المضادات الحيوية.
- قد لا يلتئم الجرح بشكل طبيعي. الندبة الناتجة قد تكون سميكة ذات لون أحمر ، وقد تكون مؤلمة. هذا الأمر يدوم إلى الأبد وقد يكون مشوهاً.
- فقدان الإحساس في الحلمة إذا كانت الجراحة بالقرب منها يستمر ذلك للأبد.
- مواجهة صعوبة في تحريك الذراع بسبب تصلب مفصل الكتف ووجود تندب تحت الذراع بعد إجراء العملية. يكون ذلك بشكل مؤقت عندما تتم معالجته بالعلاج الطبيعي و/أو التمارين.
- تورم في الذراع (الاستسقاء الليمفي) في الجهة التي أجريت فيها الجراحة. وتعالج عادةً بارتداء نوع خاص من الملابس والتي تقوم بالضغط على الذراع لتقليل تراكم السوائل. قد يساعد أيضاً القيام بالتدليك المعتاد (المساج).
- فقدان الجنسية (عدم الميل لممارسة النشاطات الجنسية) بسبب ما يمر به المريض من محنة وضغوط وبسبب تغير صورة ومظهر الجسد أو بسبب الاكتئاب المصاحب للمرض. قد يساعد في التغلب على ذلك الحصول على الاستشارات الملائمة من جهات محترفة قبل وبعد إجراء الجراحة.
- قد يعود الورم للنمو مرة أخرى في ندب الجراحة أو حوله. قد يتطلب ذلك معالجات لاحقة عن طريق الجراحة ، العلاج الكيميائي ، العلاج الإشعاعي ، أو كل هذه الطرق العلاجية مجتمعة.
- الشعور بالتوتر والكآبة بسبب المرض واحتمالية تكوّنه وعودته مرة أخرى.
- عند المدخنين ، تزداد مخاطر عدوى والتهابات الجرح والصدر

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

infections, heart and lung complications and thrombosis.

Further risks if sentinel lymph node biopsy performed:

- Small risk of incorrect information (ie negative sentinel lymph node biopsy) with positive axillary (armpit) nodes being left behind.
- There is a 1% or less possibility that subsequent treatment decisions will be altered by such information.
- If sentinel lymph node biopsy is positive, then it is likely that formal axillary dissection (cutting up of) will be required, with attendant risks of that procedure.
- If sentinel lymph node biopsy is unable to be located at the time of surgery, the axillary dissection will be performed immediately (there is a possibility that the technique did not work because of malignant - cancerous - lymph nodes).
- Sometimes the sentinel lymph node is an unusual site, such as the internal mammary nodes (between the ribs) where a further incision may be required with temporary partial separation of the ribs. There is a small risk of lung injury and bleeding in this situation.
- Possibility of an additional incision depending on the location of the sentinel lymph node - this will not be known until immediately prior to the operation.
- Small risk of permanent skin staining from the blue dye used.
- Allergy to the blue dye.
- Passage of blue/green urine for a short time after surgery (because of the blue dye used).
- Small radiation risk (from the nuclear study to localise the sentinel lymph node) if pregnant.

D. Significant Risks and Procedure Options

، مضاعفات القلب والرئة ، و تجلطات الأوعية الدموية.

مخاطر إضافية عند القيام بأخذ عينة (خزعة) من العقد الليمفاوية الحارسة (الأسرع في الإصابة بالمرض):

- مخاطر ضئيلة جراء معلومات خاطئة (كنتيجة عينة سلبية للعقدة الحارسة) مع وجود عقد ليمفاوية ذات نتائج إيجابية في الإبط تم تركها.
 - وهناك احتمالية بنسبة 1% أو أقل بأنه سيتم تغيير القرارات العلاجية اللاحقة بسبب هذا الخطأ في المعلومة.
 - إذا كانت نتيجة عينة العقدة الليمفاوية الحارسة إيجابية ، فإنه على الأرجح أن يتطلب ذلك إجراء الجراحة التشريرية للإبط (القطع باتجاه الأعلى) مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بها.
 - إذا تعذر إيجاد العقدة الليمفاوية الحارسة أثناء إجراء الجراحة، فسيتم فوراً إجراء الجراحة التشريرية للإبط (هناك احتمال بأن التعذر في تحديد العقدة هو بسبب وجود عقد ليمفاوية سرطانية).
 - في بعض الأحيان تكون العقدة الليمفاوية الحارسة في غير مكانها المعتاد مثل العقد الثديية الداخلية (بين الأضلاع) ، مما قد يتطلب إحداث شق جراحي مع مبادعة جزئية ومؤقتة بين الأضلاع. وفي هذه الحالة توجد مخاطر ضئيلة من حدوث جرح للرئة ونزيف.
 - هناك احتمال بظهور الحاجة لإحداث شق جراحي إضافي ، ويتوقف ذلك على موقع العقدة الليمفاوية الحارسة ، ولا يمكن تحديد ذلك إلا مباشرة قبل بدء التدخل الجراحي.
 - مخاطر ضئيلة من تلطّخ الجلد (تغيّر دائم في لون الجلد) بسبب الصبغة الزرقاء التي تم استخدامها.
 - تفاعل تحسسي للصبغة الزرقاء المستخدمة.
 - تغيير لون البول (أزرق- أخضر) لفترة وجيزة بعد إجراء الجراحة بسبب الصبغة الزرقاء المستخدمة.
 - عند الحوامل ، توجد مخاطر ضئيلة ناتجة عن فحص التصوير النووي لتحديد موقع العقدة الليمفاوية الحارسة.
- د. مخاطر كبيرة وهامة وخيارات الفحص**

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the procedure will improve my condition even though it has been carried out with due

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

هـ. مخاطر عدم إجراء الفحص

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المكان المحدد ، ويكمل في سجل المريض الطبي إذا اقتضى الأمر)

و. التخدير

قد يتطلب القيام بهذا الإجراء الخضوع للتخدير. (يقوم الطبيب المعالج بتدوين نوع التخدير الذي تمت مناقشته مع المريض)

ز. إقرار المريض

أقر بأن الطبيب قد شرح لي :

- حالتي المرضية والإجراء المقترح ، بما في ذلك الإجراءات العلاجية الإضافية في حالة اكتشاف الطبيب لأمر لم يكن متوقعاً . أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- التخدير المطلوب لهذا الإجراء. أقر بأنني أتفهم المخاطر بما في ذلك المخاطر الخاصة بحالتي الصحية.
- الخيارات الإجرائية الطبية والعلاجية الأخرى ذات الصلة والمخاطر المترتبة عليها.
- المسار الطبيعي لحالتي المرضية ومخاطر عدم القيام بالإجراء.
- عدم تقديم أي ضمانات لي بأن الإجراء سيؤدي إلى تحسن حالتي المرضية بالرغم من أن الإجراء سيتم بمهنية عالية.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ **About Your Anaesthetic**
- ☐ **Wide Local Excision +/- Sentinel Lymph Node Biopsy**
- ☐ **Blood & Blood Products Transfusion**

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

• قد يشتمل الإجراء نقل دم لي .

- احتمالية إزالة أنسجة أو دم ، وقد يستخدمان في تشخيص أو علاج حالتي المرضية ويتم حفظها والتخلص منها عن طريق المستشفى بطريقة مهنية تراعي الأنظمة والأعراف.
- إذا حدث (لاسمح الله) ما يهدد حياتي أثناء الإجراء ، فسيتم التعامل معه حسب ما تم شرحه لي من قبل الطبيب أو حسب خطة الإنعاش المحددة لي .

• قد يقوم بالإجراء طبيب آخر غير الاستشاري ، وأنا مدرك تماماً أن هذا الطبيب منخرط في برنامج تدريبي متقدم.
لقد تم إعطائي مستندات وأوراق التعليمات التالية:

☐ نوعية التخدير المقدم لي

☐ الإزالة الموضعية واسعة النطاق +/- أخذ عينة (خزعة) للعقد الليمفاوية الحارسة (الأسرع في الإصابة بالمرض)

☐ نقل دم و مشتقات الدم لي

- منحت لي الفرصة من قبل طبيبي لطرح أسئلتني والتعبير عن مخاوفي فيما يخص حالتي المرضية والإجراء المقترح ومخاطره ، والخيارات المتوفرة لعلاجي. وقد تم الرد على استفساراتي ومخاوفي بما حقق لي الرضا.
 - أتفهم أن من حقي تغيير رأيي في أي لحظة حتى ولو حدث ذلك بعد توقيعي لهذا النموذج ، ولكن من الأفضل أن يتم ذلك بعد مناقشته مع طبيبي.
 - أتفهم أنه قد يتم خلال الإجراء أخذ صور طبية أو تسجيل مقاطع فيديو تخص المرض وذلك كجزء من الإجراء وان ذلك سيتم خلاله، وأن هذه الصور والمقاطع المصورة ستساعد الطبيب على اختيار أنسب طرق العلاج.
- وبناء على ما تقدم، فإنني أوافق على الخضوع للإجراء الطبي

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of

Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

اسم المريض :

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

المرضى فاقدى القدرة على إعطاء الإقرار
يتم الحصول على الإقرار من قبل شخص/ أشخاص بديل مناسب
ينوب عنه ويملك المقدرة على اتخاذ القرار على النحو الموضح
أدناه.

اسم من ينوب/ينوبون عن المريض في اتخاذ القرار :

التوقيع :

صلته بالمريض :

التاريخ: الوقت:

رقم الإتصال:

ح . بيان الطبيب / مندوب الطبيب

لقد شرحت للمريض كل النقاط المذكورة سابقاً في قسم إقرار
المريض (ز) ، وأنا على ثقة بأن المريض / من ينوب عنه قد فهم
جميع المعلومات المقدمة له .

اسم الطبيب/ مندوب الطبيب:

طبيعة الإنابة:

التوقيع :

التاريخ: الوقت:

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت: _____